

23. ENTWICKLUNG DER SPEISERÖHRE

DAUER : 07:43

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video befasst sich eingehend mit der Entwicklung der Speiseröhre und beleuchtet ihre wesentliche Rolle als Gelenk zwischen Geist und Herz. Es wird der Einfluss der embryonalen Flexion auf den Rumpf behandelt, die das Verdauungssystem formt und die Bildung von Lunge und Speiseröhre ermöglicht. Ein Schwerpunkt liegt auf der adaptiven Struktur der Speiseröhre, ihrer Verbindung zum Zwerchfell und den Folgen von Dysfunktionen, insbesondere in Bezug auf Reflux und HNO-Probleme. Die dynamischen Wechselwirkungen zwischen Speiseröhre, Luftröhre und Aorta offenbaren eine rhythmische Komplexität, die für unsere allgemeine Gesundheit entscheidend ist. Anhand von Schlüsselkonzepten wie dem Vagusplexus und der Peritonealgefäßversorgung beleuchtet diese Lektion die Bedeutung des embryonalen Systems für die osteopathische Praxis.

ENTWICKLUNG DER SPEISERÖHRE

Die Entwicklung der **Speiseröhre** ist eine Artikulation zwischen dem **Mentalen** und dem **Herzen**. Die **Aorta** spielt eine zentrale Rolle in diesem System, während die **Amnionhöhle** einen äußeren Druck ausübt. Zwischen diesen beiden Elementen lenkt das **Gehirn** die Entwicklung und das **Herz** dient als Stützpunkt.

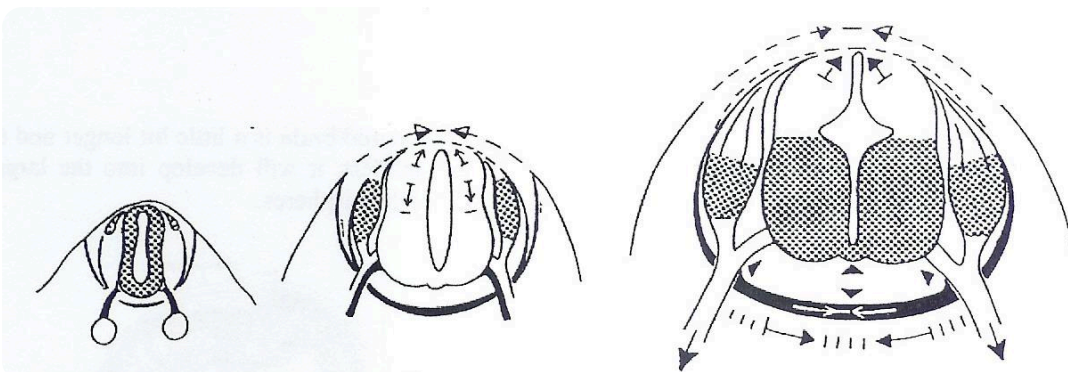


ABB. — Gastrulation Neurulation Invagination

Wir haben zuvor den Einfluss der Applikatur der Beugebewegung des Embryos auf Kopfhöhe untersucht. Nun werden wir den Einfluss dieser Applikatur auf **Rumpfhöhe** betrachten. Diese Beugebewegung erzeugt verschiedene Verdauungsphänomene.

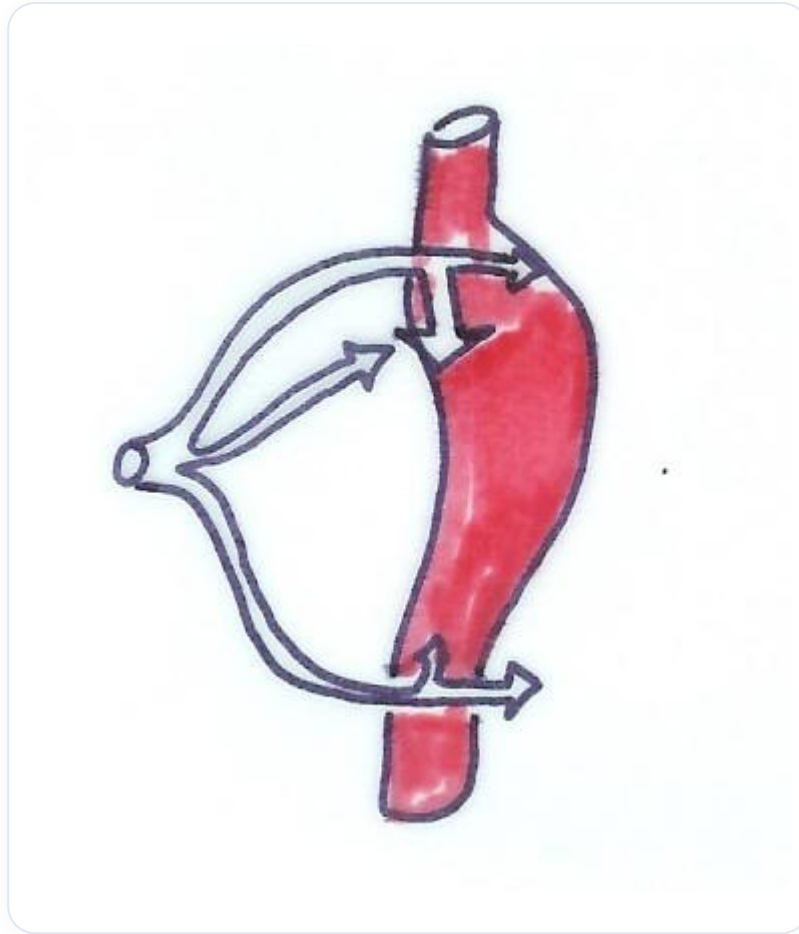


ABB. — Fetalzirkulation

Eines der ersten zu untersuchenden Verdauungsphänomene ist die Entwicklung der **Lungen**, die man als Drüse betrachten kann. Diese Beugebewegung involviert die **Amnionhöhle**, die **Dottersackhöhle** und das **Herz**. Wir beobachten das Auftreten des **vorderen Verdauungstrakts** mit Divertikeln. Allmählich zeichnen sich ein Lungenbereich und ein Verdauungsbereich ab.

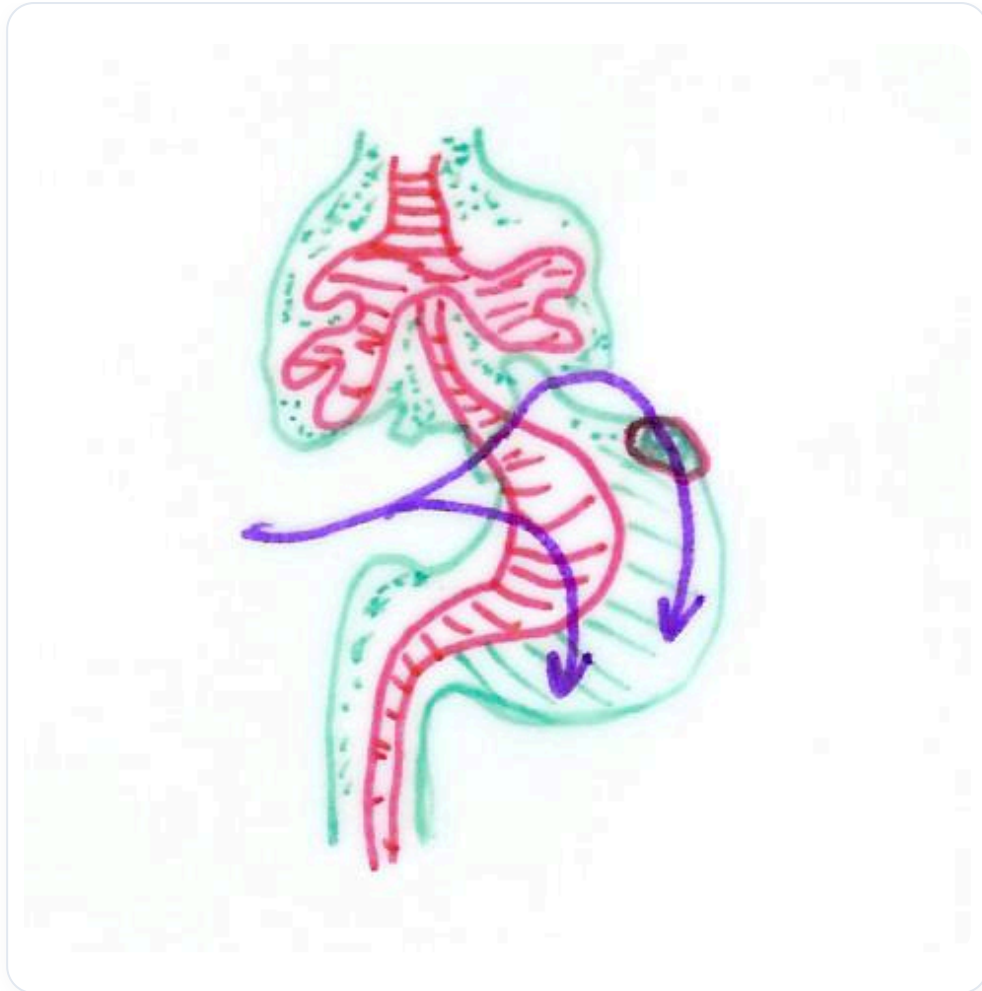


ABB. — Fetalzirkulation

Die **Speiseröhre** entwickelt sich aus dem Segment des **primitiven Darms**, das sich zwischen dem **Atemdivertikel** und der Erweiterung des **Magens** befindet. Sie besteht aus einem **endoblastischen** Teil (inneres Gewebe) und einem **Mesenchym** (Binde-, Muskel- und Fasergewebe). Das Epithel bildet den inneren Teil, während sich darum ein Gewebe befindet, das zu ihrer Struktur beiträgt.

Die **Speiseröhre** zeigt eine gewisse Anpassungsfähigkeit an ihre Umgebung. Viele Probleme an der Speiseröhrenverbindung hängen jedoch mit der Beziehung zum **Zwerchfell** zusammen. Diese Dysfunktionen können **HNO**-Probleme wie Ohrenentzündungen, Schnupfen und sogar Reflux verursachen. Elemente wie **Pepsin** und **Salzsäure** wurden im Mittelohr einiger Kinder gefunden, was den Zusammenhang zwischen Reflux und HNO-Problemen unterstreicht.

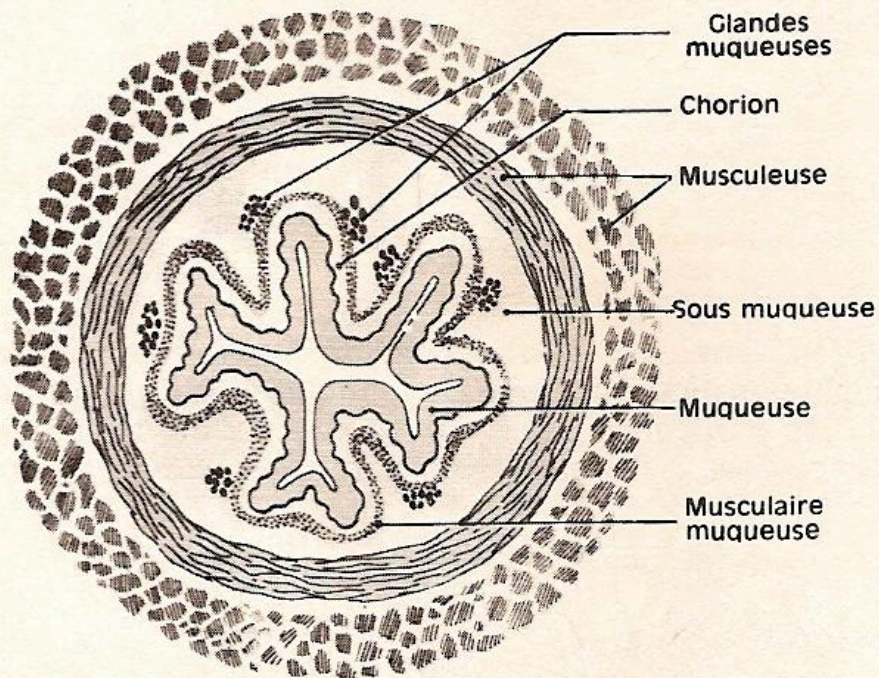


FIG. 53. — Coupe transversale de l'œsophage.

ABB. — Ösophagusschnitt

Es ist wichtig zu beachten, dass Reflux nicht immer mit Sodbrennen einhergeht. Tatsächlich gibt es gasförmige Refluxe, bei denen Gasmoleküle im System aufsteigen. Dies ist oft auf eine Dysfunktion an der Verbindung zwischen Speiseröhre und Magen, auf Zwerchfellebene, zurückzuführen.

Corte frontal esquemático del hiato esofágico.

- 1 Porción derecha del diafragma.
- 2 Músculo de Rouget y Juvara derecho.
- 3 Peritoneo.
- 4 Cardioesófago.
- 5 Válvula de Gubaroff.
- 6 Músculo de Rouget y Juvara izquierdo.
- 7 Espacio periesofágico.
- 8 Vaina de Treitz y Leimer (lado izquierdo).
- 9 Vaina de Treitz y Leimer (lado derecho).
- 10 Pleura.

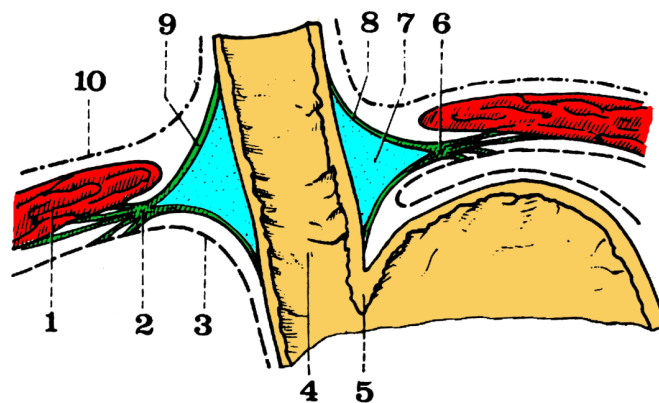


ABB. — Hiato esofágico

Die **Zwerchfellverbindung** ist entscheidend, da sie mit den **Juvara-Fasern** und dem **periesophagealen Raum** in Verbindung steht, der anpassungsfähig ist. Eine Dysfunktion auf dieser Ebene kann die Qualität und Öffnung des Zwerchfells blockieren. Steele sagte: "Wenn dein Zwerchfell nicht frei ist, ist die Tür deines Lebens nicht frei."

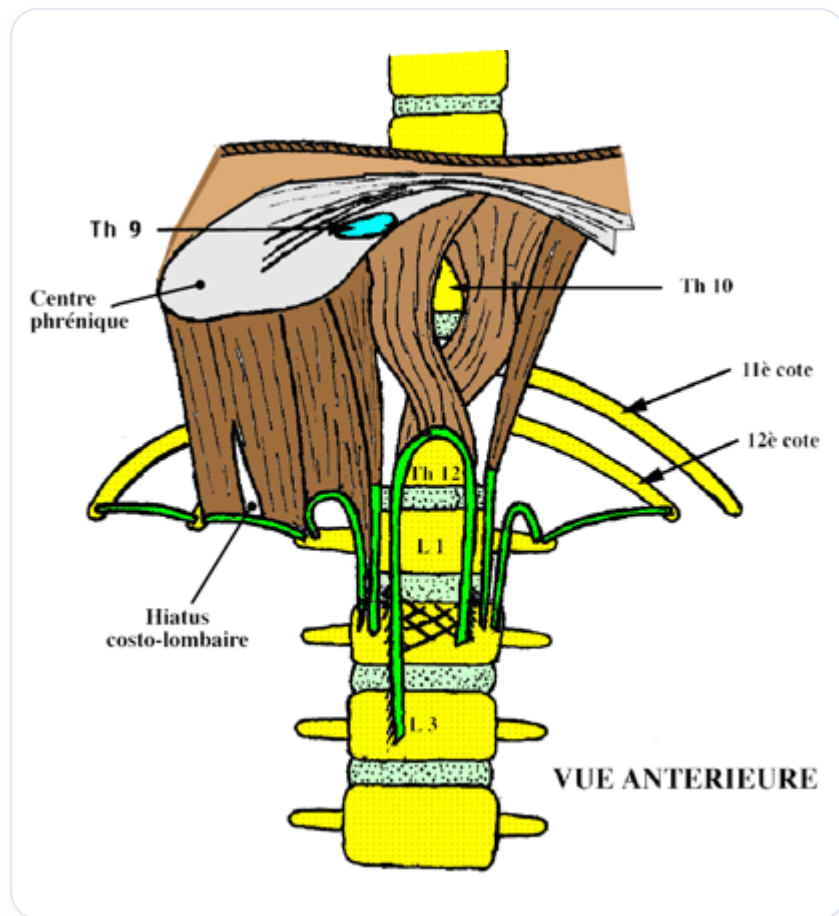


ABB. — Zwerchfell in Vorderansicht

Der **Vagusplexus** ist ebenfalls sehr wichtig. Die **Speiseröhre**, die **Luftröhre** und die **Aorta** sind miteinander verbunden und bilden eine rhythmische Zone. Diese Zone wird durch eine **gemeinsame Faszie** und ein **hinteres Mesenterium** gehalten, die an der mittleren dorsalen Zone, um D3-D4, ansetzen.

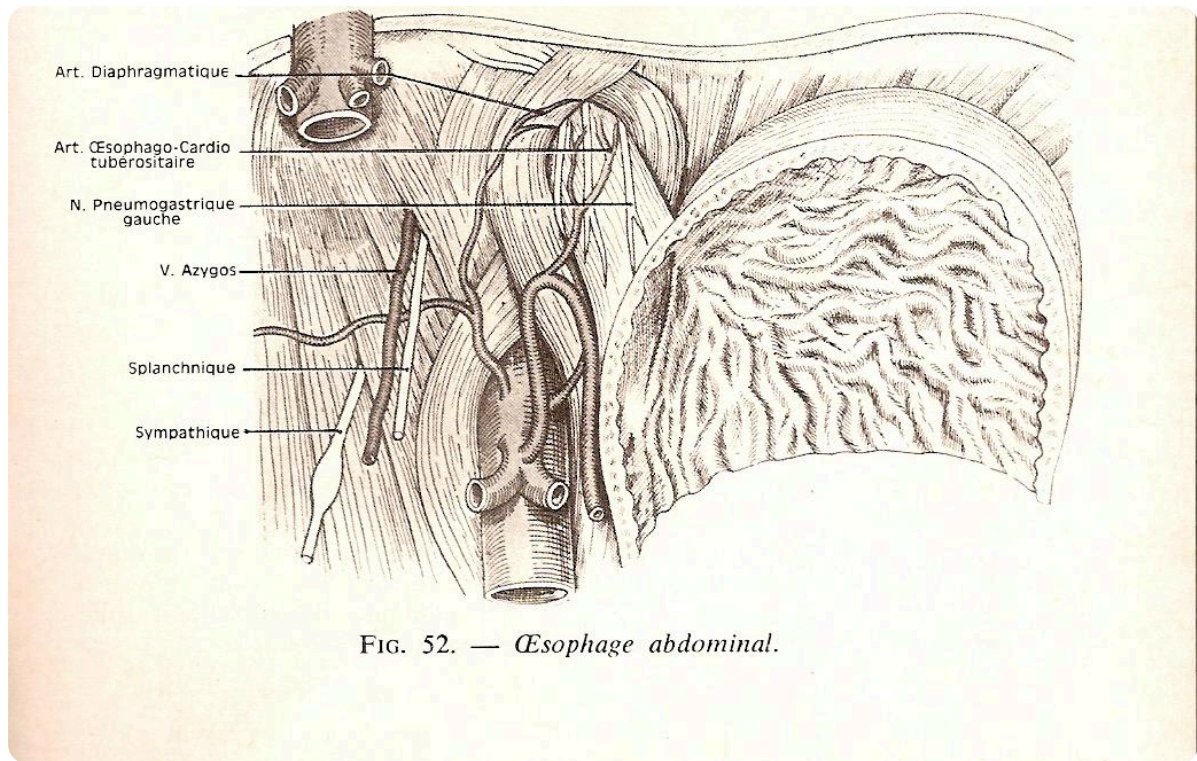


FIG. 52. — Œsophage abdominal.

ABB. — Abdominaler Ösophagus

Die **Speiseröhre** ist am Schlucken beteiligt, die **Luftröhre** an der Atmung und die **Aorta** an der Herzbewegung. Diese Interaktionen finden Tausende Male am Tag statt und erzeugen eine komplexe rhythmische Dynamik.

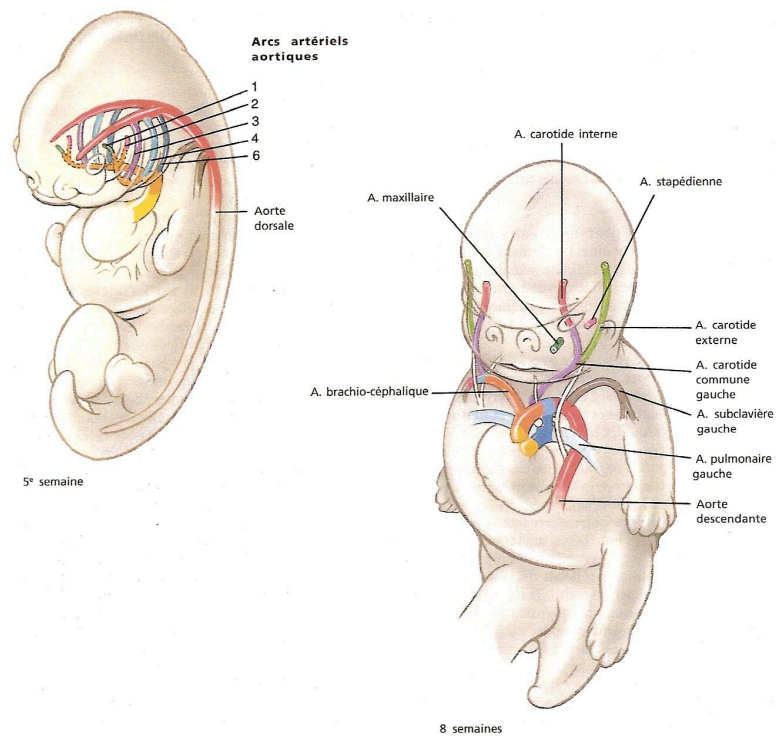


Fig. 12 - 6. Devenir des artères des arcs pharyngiens. Ces artères se modifient pour être à l'origine de celles de la partie supérieure du thorax, du cou et de la tête (voir Ch. 8).

ABB. — Embryonale Aortenbögen

Wir haben auch eine direkte Kontinuität mit dem Aortensystem sowie ein Band, das sich zum **vierten Teil des Zwölffingerdarms** erstreckt und einen wichtigen Bereich auf Höhe des **Truncus coeliacus** öffnet. Letzterer ist essentiell für die Vaskularisation des subdiaphragmalen Peritonealbereichs, der die **Leber** und den **Magen** versorgt.

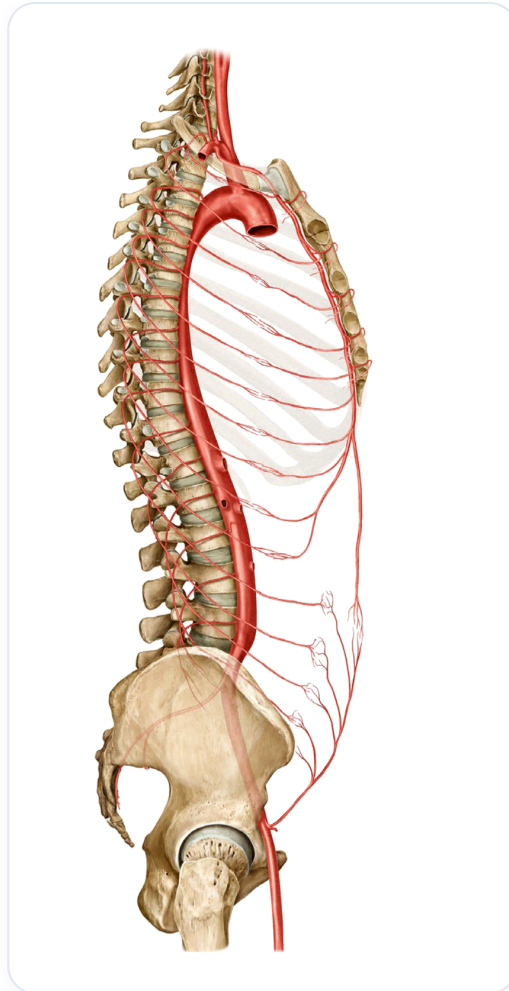


ABB. — Aorta, Bogen, Interkostalarterien

Schließlich werden wir uns der Untersuchung der **Lungen** widmen und dabei die verschiedenen Schichten der Speiseröhre und ihre Bedeutung für die Gesamtentwicklung des Verdauungssystems beleuchten.

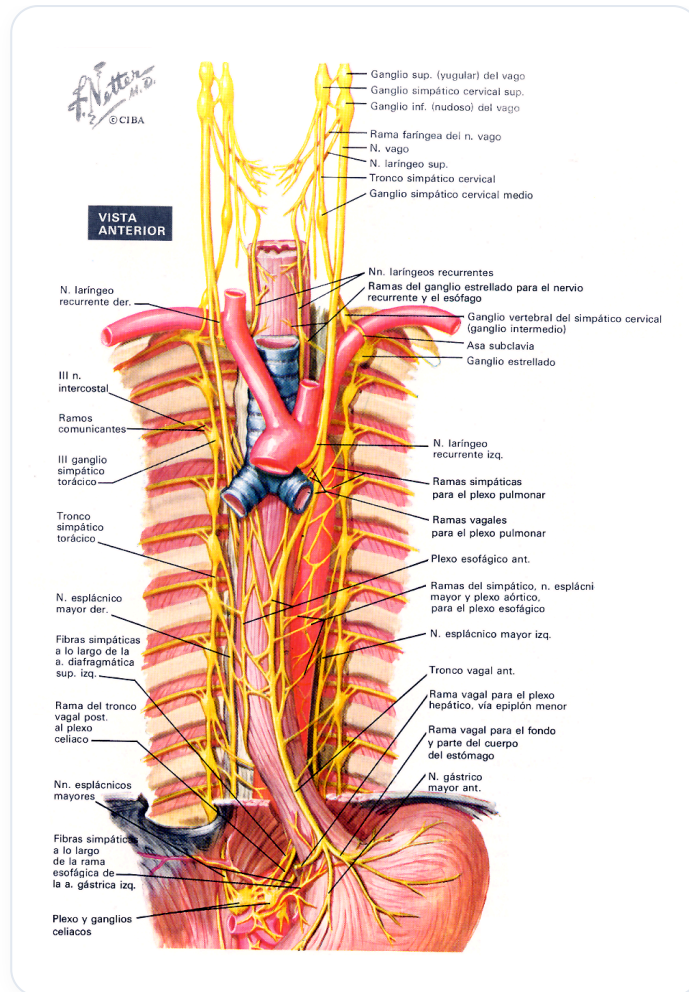


ABB. — Thorakale und abdominale Innervation